

BÉNIGNES**Papillome**

Origine virale (souvent)

Tumeurs végétantes, en saillie

Microscopie : Hyperpapillomatose, hyperacanthose, hyperkératose**Condylome**

Origine virale HPV, transmission sexuelle (souvent)

Lésion plane ou acuminée

Prolifération épithéliale, aspects cytopathogènes recherchés : koïlocytes, binucléations

MALIGNES**Carcinome épidermoïde**

Bourgeonnant, ulcère infiltrant

Carcinomes in situ / carcinome infiltrant

Cellules basales ou corps muqueux de malpighi, *desmosomes*, *kératinisation*

Cutanés

Carcinome épidermoïde des muqueuses

Voies aéro-digestives sup.

Tabac + alcool, HPV

Bronches

Tabac

Col utérin

HPV

Oesophage

Alcool et tabac

Carcinome cutané

2 types : épidermoïde et basocellulaire

Carcinome basocellulaire

Basophile, absence de différenciation (pas de kératine)

Absence de métastase

Types

Nodulaire

Trabéculaire

Superficiel

Sclérodermoïforme

TUMEURS DES ORGANES CREUX

Adénome (bénin)

Aspects de polypes (pédiculés, sessiles)

Adénocarcinome (malin)

Bourgeonnant, ulcéré, infiltrant

Carcinome mucineux (= consistance gélatineuse, sécrétion mucus)

TUMEURS COLORECTALES

Adénome (bénin)

Toujours des cellules dysplasiques, cytoplasme basophile, noyaux plus gros hyperchromatiques

Adénomes tubuleux, vilieux ou tubulo-vilieux

Adénocarcinome (malin)

Lieberkühnien

Structure glandulaire

Colloïde muqueux/mucineux

Mucosécrétion +++

À cellules dissociées

Vacuole de mucosécrétion dans cytoplasme

TUMEURS DES PARENCHYMES EXOCRINES

Adénome et Cystadénome (bénin)

Adénocarcinome (malin)

TUMEURS MAMMAIRES

Fibroadénome (bénin)

Développement du tissu conjonctif

Carcinome (malin)

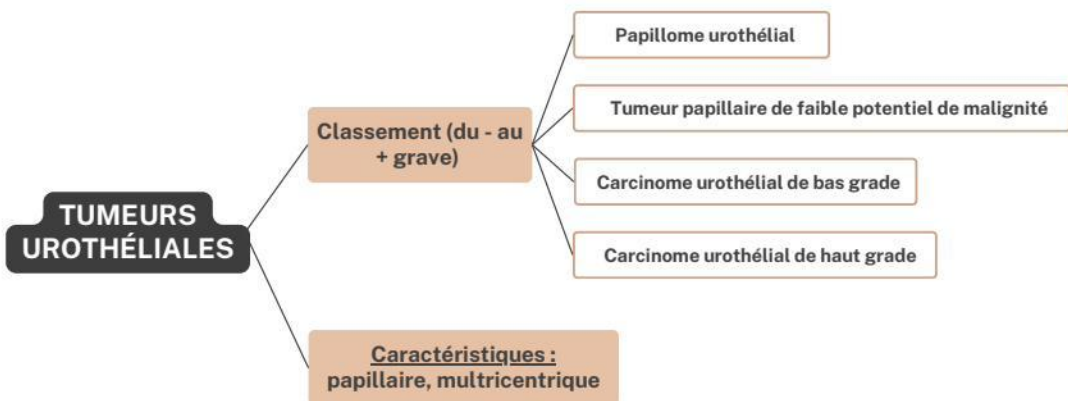
Hyperplasie canalaire atypique vers carcinome canalaire in situ

2 types : carcinome infiltrant de type non spécifique OU carcinome lobulaire infiltrant

Pronostic : grade SBR, stade TNM, angio-invasion

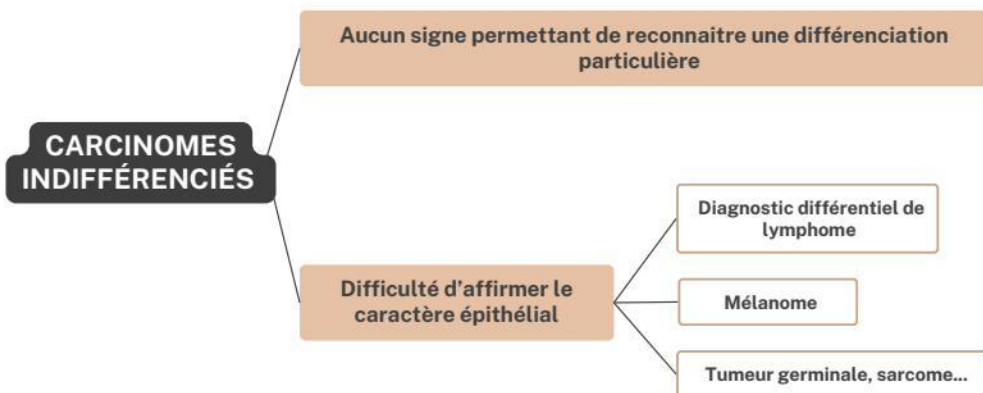
03

Les tumeurs urothéliales



04

Les carcinomes indifférenciés



Les tumeurs à différenciation endocrine

TUMEURS À DIFFÉRENCIATION ENDOCRINE

Développement

A partir de glandes endocrines individualisées ou à partir du système endocrinien diffus (TD +++)

Types de tumeur

Bénignes, malignes et endocrines à malignité intermédiaire ou indéterminée

Particularité des tumeurs du SE diffus

Sécrétion d'hormones peptidiques par l'intermédiaire de grains neurosécrétoires cytoplasmiques

Riche réseau capillaire, cytoplasme granuleux

Types de tumeur

Adénomes même si non glandulaire (thyroïde...)

Tumeurs neuroendocrines bien diff. du TD

Tumeurs carcinoïdes typiques et atypiques (poumon)

Particularité des tumeurs du SE diffus

Sécrétion d'hormones peptidiques par l'intermédiaire de grains neurosécrétoires cytoplasmiques

Pronostic

Distinction entre tumeur bénigne/maligne difficile, système de grades (prolifération et nécrose)

TUMEURS BIEN DIFFÉRENCIÉES

Fréquence

Cancer fréquent et de bon pronostic

Rareté des tumeurs malignes (corticosurrénale, parathyroïde, hypophyse)

TUMEURS MALIGNES

Carcinomes neuro endocrines (poumons surtout)

À grandes cellules

À petites cellules